

疾病照護品質認證



頭頸癌照護品質認證 評量項目

目錄

第一章、團隊運作與管理

1.1 團隊發展		
1.1.1	團隊組織架構	p. 5
1.1.2	團隊領導	p. 7
1.1.3	團隊發展計畫（含品質提升策略）	p. 7
1.1.4	年度工作計畫	p. 7
1.2 人員管理		
1.2.1	團隊人員資格	p. 9
1.2.2	人員教育訓練計畫	p. 10
1.2.3	人員職責/工作說明書	p. 11
1.2.4	人員技術評核計畫	p. 11
1.2.5	醫師授權機制	p. 11
1.3 病人安全目標及執行		
1.3.1	病人安全計畫	p. 13
1.4 風險評估、分析與應變機制		
1.4.1	團隊風險管理計畫及相關分析結果	p. 14
1.4.2	緊急災害應變計畫、演練及後送機制	p. 15

第二章、專業的臨床照護

2.1 病人規範		
2.1.1	病人收案、排除、結案之條件	p. 16
2.1.2	高危險群病人定義	p. 16
2.1.3	病人權利	p. 17
2.2 照護作業流程		
2.2.1	醫療照護計畫	p. 18
2.2.2	團隊溝通機制	p. 19
2.2.3	共病照護機制	p. 19
2.2.4	團隊運作標準作業模式	p. 20
2.2.5	病人及家屬參與疾病照護之過程及決策	p. 21
2.2.6	提供衛教資料與指導	p. 22
2.2.7	病人出院計畫	p. 22
2.2.8	高危險群病人之照護標準作業規範	p. 23
2.2.9	高風險醫療照護行為之標準作業規範	p. 23
2.2.10	手術/處置前、中、後之照護標準作業規範	p. 24
2.2.11	檢查/檢驗前、中、後之標準作業程序	p. 25
2.2.12	用藥管理	p. 26

2.3 臨床照護之紀錄品質		
2.3.1	病人治療過程、後續追蹤之紀錄	p. 28
2.3.2	病歷之標準化代號、縮寫、定義及方法	p. 28

第三章、品質提升及成果

3.1 品質監測		
3.1.1	品質監測指標	p. 29
3.1.2	品質監測機制	p. 29
3.1.3	臨床稽核計畫	p. 30
3.1.4	就醫經驗調查	p. 30
3.2 警訊事件及異常事件之通報管理流程		
3.2.1	警訊事件及異常事件之通報管理流程	p. 31
3.3 品質成效		
3.3.1	疾病照護品質提升專案	p. 32
3.3.2	臨床成效分析	p. 32
3.3.3	醫療資源之整合與利用分析	p. 33
3.3.4	資訊化成效	p. 33
3.3.5	創新照護特色展現	p. 34

第一章、團隊運作與管理

1.1 團隊發展

重點說明：團隊應有計畫地呈現整體性、連續性及以病人為中心的照護模式，管理制度應符合醫療機構組織營運的基本方針及價值觀。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
1.1.1 團隊組織架構 目的：團隊應建立專業且完整之組織，依據疾病照護需求配置合適之醫療專業人員，並有良好的分工與合作機制。 1.1.1 應符合下述規範： 1. 核心團隊成員：依據病人照護需求組成核心團隊，包含經營管理及疾病照護核心成員，核心團隊主要任務為定期召開團隊會議，訂定團隊發展目標、工作計畫等，決策團隊之發展走向，並適時檢討改善相關作業。其中疾病照護核心成員應至少包含： (1) 耳鼻喉科專科醫師。 (2) 口腔顎面外科專科醫師。 (3) 腫瘤內科專科醫師。 (4) 放射腫瘤科專科醫師。 (5) 放射診斷科專科醫師。	1. 團隊組織架構圖 2. 核心團隊成員名冊 3. 醫療照護團隊成員名冊	評量 8 分(含)以上應包含明確定義頭頸癌照護團隊組織架構，並建立跨部門之溝通管道，核心團隊成員有個案管理師。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
(6) 個案管理師。 2. 醫療照護團隊成員：除了上述核心團隊成員之外，照護該疾病病人之其他相關人員，建議包含（依團隊照護需要）： (1) 解剖病理專科醫師。 (2) 牙科醫師。 (3) 核子醫學科專科醫師。 (4) 整形外科專科醫師。 (5) 復健科專科醫師。 (6) 精神科專科醫師。 (7) 安寧緩和醫學專科醫師。 (8) 護理師。 (9) 藥師。 (10) 營養師。 (11) 社會工作師。 (12) 心理師。 (13) 語言治療師/職能治療師/物理治療師。 (14) 靈性關懷人員。 3. 團隊具有良好的組織分工，並建立跨領域成員合作機制及溝通管道。 註：經營管理相關人員係指實際負責機構營運者，可包含院長、副院長、資深		

評量項目	建議佐證文件	委員共識
主管、部門主管等。		
1.1.2 團隊領導 目的：確保團隊領導者確實參與團隊發展規劃，促使團隊能取得足夠資源、並能與相關部門合作，具良好的橫向及縱向溝通。 1.1.2 應符合下述規範： 1. 核心團隊具有良好的領導，團隊領導者有明確任務定義，主動參與團隊發展規劃，並掌握執行成效。	1. 團隊領導者名冊及工作職掌 2. 團隊會議紀錄	
1.1.3 團隊發展計畫（含品質提升策略） 目的：團隊依據機構營運方針、目標願景及照護特色，共同訂定團隊發展之短、中、長期計畫，並落實執行。 1.1.3 應符合下述規範： 1. 核心團隊依據醫療機構組織營運的基本方針及價值觀，跨領域成員共同訂定發展計畫、品質提升策略、照護監測指標及改善指標，計畫內容提報經營管理層級會議核定，並落實執行與檢討改善。 2. 跨領域成員亦共同參與定期檢討，且有持續改善作為。	1. 團隊之短、中、長期發展計畫 2. 團隊之品質提升計畫	有關應符合規範第 1 點所提「計畫內容提報經營管理層級會議核定」，係指提報至全院性會議即可，如：醫療品質相關會議、腫瘤委員會等。
1.1.4 年度工作計畫 目的：團隊依據發展計畫，於新一年度開始前進行討論及分析檢討，以利擬定次一年度工作計畫。	1. 團隊之年度工作計畫 2. 計畫執行成果	1. 評量 6 分(含)以上應包含頭頸癌照護團隊訂有年度工作計畫。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
1.1.4 應符合下述規範： 1. 核心團隊依發展計畫，跨領域成員共同訂定明確可行之團隊年度工作計畫，並確實執行。 2. 定期監測工作計畫及疾病照護計畫之執行成果，並落實檢討改善。	檢討及改善紀錄	2. 評量 8 分(含)以上應包含頭頸癌照護團隊有多職類一同參與訂定年度工作計畫；評量 9 分(含)以上應包含有進一步參與定期檢討，且有持續改善作為及 PDCA 計畫。

1.2 人員管理

重點說明：照護團隊應建立良好的組織運作機制及配置適當的醫療專業人員，且人員應接受該疾病照護之相關教育訓練及照護技術評核，並瞭解自身於團隊中的職責，俾能充分發揮照護效能。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
1.2.1 團隊人員資格 目的：團隊各職類成員應具備該疾病照護專業能力，以符合病人照護的需求。 1.2.1 應符合下述規範： 1. 團隊成員具備該疾病照護專業能力，依據疾病需求、照護功能及工作需要，訂定聘任資格條件，如：教育背景、經驗、訓練、證照之有效性等。 2. 核心團隊成員之證照、訓練要求： (1) 耳鼻喉科專科醫師：具專科醫師證照。 (2) 口腔顎面外科專科醫師：具專科醫師證照。 (3) 腫瘤內科專科醫師：具專科醫師證照。 (4) 放射腫瘤科專科醫師：具專科醫師證照。 (5) 放射診斷科專科醫師：具專科醫師證照。 (6) 個案管理師：具護理師證照，且至少須於到職一年內完成台灣護理學會、台灣腫瘤護理學會所舉辦或認可之腫瘤個案管理護理師培訓課程（上課證明至少 50 小時積分） 3. 醫療照護團隊成員之證照、訓練要求：具專科醫師／醫事人員證照。	1. 團隊成員專業證照 2. 團隊成員教育訓練證明	評量 8 分(含)以上應包含核心醫療團隊之醫師（耳鼻喉科醫師、口腔顎面外科醫師、腫瘤內科醫師、放射腫瘤科醫師）需有 50%(含)以上為台灣頭頸部腫瘤醫學會會員，且有頭頸癌照護專屬病房。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
1.2.2 人員教育訓練計畫 目的：團隊應針對各職類人員訂定教育訓練內容及時數，依據核心團隊及醫療照護團隊成員所需之照護知能，規範人員應達成之相關課程及訓練。 1.2.2 應符合下述規範： 1. 團隊應依該疾病照護所需知能（如：病人需求、照護功能及工作需要），訂定並執行人員教育訓練計畫，計畫內容應包含核心團隊、醫療照護團隊之職前教育訓練及在職與進修教育訓練，並適時檢討教育訓練計畫及有相關佐證之資料。 2. 團隊應訂定年度教育訓練計畫，且應符合以下規範： (1) 核心團隊成員每年須接受頭頸癌照護相關之教育訓練課程至少 4 小時。 (2) 醫療照護團隊成員每年須接受頭頸癌照護相關之教育訓練課程至少 1 小時。 註 1：職前教育訓練係指進入照護團隊前的教育訓練。 註 2：核心團隊及醫療照護團隊成員，其資格請參考評量項目 1.2.1 之規範。	1. 團隊年度教育訓練計畫 2. 團隊成員教育訓練證明	1. 評量 6 分(含)以上應包含頭頸癌照護核心照護團隊訂有年度教育訓練計畫。 2. 評量 8 分(含)以上應包含頭頸癌醫療照護團隊（非核心照護團隊）訂有頭頸癌照護相關教育訓練，並有佐證資料。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
1.2.3 人員職責/工作說明書 目的：團隊應依據疾病需求、照護功能及工作需要，明定各職類人員職責。 1.2.3 應符合下述規範： 1. 團隊成員具備該疾病照護專業能力，依據疾病需求、照護功能及工作需要，訂定醫療照護成員之工作說明書。	團隊成員工作說明書	醫療照護團隊成員宜皆符合本項基準之評量說明內容，尤其醫師、護理師、個管師、營養師、心理師、復健師等 6 職類人員皆應符合評量項目規範。
1.2.4 人員技術評核計畫 目的：團隊應針對各職類人員訂定專業實務技術評核項目，內容應符合照護病人之專業。 1.2.4 應符合下述規範： 1. 團隊成員具備該疾病照護專業能力，擬訂醫療照護成員之專業實務技術評核計畫，確保執行者具有相對應之經驗與技能，評核內容應含專業實務技術項目。	1. 團隊成員技術評核計畫 2. 團隊成員技術評核紀錄	醫療照護團隊成員宜皆符合本項基準之評量說明內容，尤其醫師、護理師、個管師、營養師、心理師、復健師等 6 職類人員皆應符合評量項目規範。
1.2.5 醫師授權機制 目的：團隊應落實高風險醫療執行項目的管理，訂有授權機制。 1.2.5 應符合下述規範： 1. 團隊訂有評核執行高風險醫療行為之醫師授權機制，含授權審核項目、重	醫師授權機制及相關文件(如：主治醫師授權表等)	評量 6 分(含)以上應包含有醫師授權機制。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
新授權機制。		

1.3 病人安全目標及執行

重點說明：團隊依病人疾病照護需求，擬定並落實病人安全計畫於疾病照護過程，且將病人安全之資訊傳遞給各類人員。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
1.3.1 病人安全計畫 目的：團隊應依據照護疾病特性，擬定適切之病人安全計畫，並營造重視醫療品質及病人安全之文化。 1.3.1 應符合下述規範： 1. 團隊應依據全院性病人安全制度為基礎，如：病人安全年度目標、任務及執行方針，針對該疾病照護特性擬定病人安全計畫，評估照護過程相關之病人安全問題，並落實執行以保障病人安全。 2. 依各類人員於病人安全之需求，提供教育訓練計畫與方案。 3. 團隊定期收集該疾病之病人安全、醫療品質相關資料（如：核心測量指標、健保品質指標、台灣臨床成效指標(TCPI)、病人安全文化調查(PSC)等）並進行分析，檢討結果及改善措施呈現於年度發展計畫、年度工作及教育訓練計畫。 4. 針對新興傳染性疾病應訂有相關因應機制，如可能受感染病人之辨識流程(identify patients at risk)、處置流程的防護等。	1. 病人安全計畫 2. 團隊年度教育訓練計畫	1. 評量 8 分(含)以上應包含以病人安全年度目標為基礎，針對頭頸癌照護特性訂定安全目標並落實執行；評量 9 分(含)以上應包含有進一步檢討改善及 PDCA 計畫。 2. 僅以全院性病人安全年度目標為基礎，不得評量高於 6 分。

1.4 風險評估、分析與應變機制

重點說明：團隊依病人疾病照護需求應運用風險分析工具（如：災害脆弱度分析(Hazard Vulnerability Analysis, HVA)或異常事件嚴重度評估風險矩陣(Severity Assessment Code, SAC)），評估可能發生風險或緊急事件，並依據分析結果研擬風險管理計畫，降低安全風險，並使團隊人員熟悉處理程序並有檢討之機制，以確保人員及病人安全。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
1.4.1 團隊風險管理計畫及相關分析結果 目的：團隊應用風險分析工具，依據疾病照護特性進行危害及異常事件嚴重度評估風險分析，且依據分析結果進行排序，並擬定風險管理計畫，進行檢討改善及演練。 1.4.1 應符合下述規範： 1. 應用風險分析工具，由團隊成員針對該疾病照護特性，共同評估照護過程可能發生的危機或緊急事件，並與醫院風險/危機管理委員會討論，訂定團隊風險管理計畫。 2. 依據團隊風險管理計畫，針對該疾病照護相關單位及已發生或預期發生之異常事件進行危害分析。 3. 依據緊急應變演練結果或已發生之危機事件應變結果，能進行檢討與原因分析，並適時修正團隊風險管理計畫。 4. 上述團隊風險管理計畫應針對該疾病照護特性進行討論，並有相關資料佐證。	1. 團隊之風險管理計畫 2. 危害分析相關表單（如災害脆弱度分析評分表）及結果 3. 異常事件嚴重度評估風險矩陣分析結果	1. 評量 8 分(含)以上應包含針對頭頸癌照護特性進行風險評估並落實執行；評量 9 分(含)以上應包含有進一步檢討改善及 PDCA 計畫。 2. 僅以全院性風險評估為基礎，不得評量高於 6 分。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
1.4.2 緊急災害應變計畫、演練及後送機制 目的：團隊應依據風險管理計畫，訂定緊急災害應變計畫、演練及後送機制，並使團隊成員熟悉執执行程序。 1.4.2 應符合下述規範： 1. 依據團隊風險管理計畫，訂定符合機構、疾病特性及災害特性之緊急災害應變計畫，以提供安全就醫環境，降低緊急災害對病人照護的衝擊，並有定期檢討。 2. 緊急應變相關措施與團隊人員之認知，確實符合機構緊急災害應變計畫的規定。 3. 因應新興傳染性疾病訂有持續性該疾病別照護機制。	緊急災害應變計畫及後送機制	1. 評量 6 分(含)以上應包含照護團隊有針對頭頸癌進行討論，並有相關資料佐證。 2. 評量 8 分(含)以上應包含以頭頸癌照護相關急性災害訂定應變計畫，並有定期檢討；評量 9 分(含)以上應包含針對應變計畫進行演練。

第二章、專業的臨床照護

2.1 病人規範

重點說明：團隊應明定病人收案、排除、結案之條件，並重視病人安全及權利，每位病人皆能接受一致性且適當的醫療照護。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
2.1.1 病人收案、排除、結案之條件 目的：團隊應明訂病人收案、排除、結案之條件，建立相關機制納入個案管理，提供病人高品質、連續性的醫療照護。 2.1.1 應符合下述規範： 1. 明確定義病人收案、排除、結案之條件。 2. 建議收案條件：ICD-10-CM 代碼 C00-C06、 C09-C10、 C12-C14（口腔癌含口咽及下咽等）之病理診斷為鱗狀上皮細胞癌（SCC），以及 ICD-10-CM 代碼 C11（鼻咽癌）。 註：機構可依自身特色自行訂定收案條件，應考量照護量能，訂定適當的收案條件，以及個案管理合理之收案病人人數。	病人收案、排除、結案之條件	
2.1.2 高危險群病人定義 目的：團隊應明訂照護過程中之高危險群病人定義，並依據高危險群病人特性訂有照護之標準作業程序，以維護病人安全及品質。 2.1.2 應符合下述規範：	於疾病照護過程中，屬高危險群病人之定義	

評量項目	建議佐證文件	委員共識
1. 依據該疾病照護過程，明確定義高危險群病人。 2. 高危險群病人，應至少包含： (1) 治療造成第四級副作用之病人（依 CTCAE 最新版之定義）。 (2) 嚴重共病症病人（心、肺、肝、腎功能嚴重不全）。 (3) 接受化療之活動性 B 型肝炎病人。 (4) 高齡（70 歲以上）且有虛弱症病人。		
2.1.3 病人權利 目的：機構應維護病人及家屬權利，落實於照護過程之中，且適時向病人及家屬說明。 2.1.3 應符合下述規範： 1. 為維護病人及家屬權利，訂有相關政策或規範，並公告週知，包括：具體列明就醫病人的權利內容，對住院病人應參考衛生福利部公告之「醫院住院須知參考範例」制訂住院病人的權利及義務，並納入住院須知，以利向病人或家屬說明。 2. 團隊成員瞭解病人的權利內容，於照護過程中落實向病人或家屬說明，並予以尊重。 3. 定期稽核各項政策、規範的落實程度，並據以檢討、修訂、改善，並有納入病人或家屬代表的意見。	1. 病人權利說明內容 2. 團隊會議紀錄	

2.2 照護作業流程

重點說明：團隊照護病人應遵循以病人為中心的照護模式，在跨領域照護團隊合作下，依病人個別需求及急迫性，訂定照護計畫，為提供相同水準的臨床照護，兼具實證醫學精神，降低錯誤發生之機率，應明訂並落實醫療照護指引及照護技術標準，並配合醫療內容變化，適時檢討及修訂，以實行持續性、一致性、安全且優質的醫療服務。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
2.2.1 醫療照護計畫 目的：團隊依據團隊任務、願景目標、服務對象及照護特色，由跨領域成員以實證醫學方式共同訂定合適團隊之醫療照護計畫及照護指引，定期檢視內容，適時檢討修訂。 2.2.1 應符合下述規範： 1. 照護計畫由團隊跨領域成員共同討論後訂定，應明確定義團隊任務、目標、服務對象（含收案、排除、中斷及離開照護計畫之條件），並提供具可近性之醫療照護計畫（紙本或電子檔）予團隊成員取得。 2. 依病人病況、個別需要及急迫性，參考以實證醫學(EBM)為基礎之國內外臨床照護指引(Clinical Guideline)，並依據照護內容訂定相關可行之醫療照護計畫。 (1) 評估病人需要訂定含生理、心理、社會各層面之疾病照護計畫。 (2) 照護計畫內容依病人及家屬之照護需求擬訂，持續評估、修正和執行內容。	1. 醫療照護計畫 2. 團隊之臨床照護指引 3. 團隊公告文件機制	1. 評量 6 分(含)以上應包含治療計畫書有依據治療指引訂定；評量 8 分(含)以上應包含每年檢討修正。 2. 評量 8 分(含)以上應包含臨床照護計畫有公開機制並定期檢討。 3. 評量 8 分(含)以上應包含頭頸癌照護團隊進行跨領域討論時，心理師有將個案納入團隊會議討論並有評

評量項目	建議佐證文件	委員共識
(3) 協助病人及家屬瞭解病人的問題及疾病照護計畫。 3. 定期檢視臨床照護計畫內容，參考臨床照護計畫執行狀況，適時檢討修訂。 4. 臨床照護計畫於訂定後，團隊成員皆熟知修正後內容，且應有評估確認機制，以確保適用於目標族群及實務操作。		估病人心理層面問題。
2.2.2 團隊溝通機制 目的：團隊應建立良好的跨領域溝通機制，透過資訊系統的輔助，促成良好、有效的橫向溝通，以共同照護病人。 2.2.2 應符合下述規範： 1. 建立團隊成員間的溝通管道，透過醫院資訊系統提升團隊橫向溝通機制（含分析、檢討及改善），並於病人照護過程中呈現合作方式。 2. 建立團隊成員有效溝通的標準作業程序。 (1) 訂定並執行醫療照護及傳送人員交班、交接與轉運病人標準作業程序。 (2) 訂定醫囑執行標準作業程序，包含一般醫囑及緊急醫囑執行方式（含口頭醫囑/電話醫囑）。接收者對口頭醫囑/電話醫囑應由執行醫囑者進行口頭醫囑複誦(verbal order read back)，且與給予醫囑者確認。	1. 團隊溝通機制與相關紀錄 2. 團隊之交班、接班與轉送病人標準作業程序 3. 醫囑執行標準作業程序	評量 8 分(含)以上應包含急診、住院或其他科收治團隊之收案病人，有相關機制通知核心醫療團隊成員。
2.2.3 共病照護機制 目的：針對同時罹患多項疾病之病人，團隊應訂有共病照護機制，提供病人整合性的照護模式。	1. 病人評估機制 2. 共病照護機制	

評量項目	建議佐證文件	委員共識
2.2.3 應符合下述規範： 1. 經評估病人若同時發生多項疾病或受到多種臨床照護計畫管理時，能及時將資訊傳達給適當之臨床照護人員，經團隊協調後提供適當的治療或處理。 2. 團隊應制定共病照護機制，並定期檢討及持續改善。		
2.2.4 團隊運作標準作業模式 目的：團隊應訂有醫療照護團隊運作標準模式，團隊成員皆能瞭解病人個別問題與診斷，提供適時且適切的評估、醫療處置及照護。 2.2.4 應符合下述規範： 1. 訂定並執行醫療照護團隊運作標準模式，包含： (1) 設定照護團隊介入的時間表(Time Frame)。 (2) 依據時間表所列時程，各職類人員進行初次評估(Initial Evaluation)，且須包含生理、心理及社會等層面之評估。 (3) 召開核心團隊及醫療照護團隊會議，進行團隊評估。 (4) 依據病人需求與問題優先順序，進行照護計畫擬訂並設定目標。 (5) 依據追蹤時程評估病人狀況是否符合目標，且當發生新的問題時應有再評估機制。 2. 照護人員能以團隊合作模式，清楚瞭解病人個別問題與診斷，訂定並確實	1. 團隊運作標準作業模式 2. 病人診療計畫 3. 病歷紀錄	評量 8 分(含)以上應包含有跨團隊機制，並定期檢討及持續改善。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
執行每位病人診療計畫。 3. 當病人病情變化時，能提供適時且適切的評估、醫療處置及照護，並將追蹤後續變化記載於病歷。		
2.2.5 病人及家屬參與疾病照護之過程及決策 目的：團隊應推動病人、家屬參與醫病共享決策之過程，協助病人瞭解疾病、臨床進程、治療選擇的意義，以提升醫病溝通的效率。 2.2.5 應符合下述規範： 1. 即時與有效的向病人及家屬傳達病情與治療計畫，包含所獲得之醫療照護、相關資源及諮詢管道，協助病人及家屬獲取相關資訊。 2. 團隊應主動提供疾病、處置方案和可能的選擇等進一步資訊，鼓勵病人及家屬參與醫療決策討論，並尊重其決定、建立醫病共識，維護其醫療自主權。 3. 制訂政策及指引，推動病人、家屬積極參與醫病共享決策之過程(Shared Decision Making)，並評估執行成效。 4. 對於病人及家屬參與醫療照護過程與決策，有具體成效。 5. 訂有提供需要安寧照護服務需求病人的作業流程或標準規範，必要時，召開家庭會議，協助提供出院病人準備計畫，如：病危自願返家之家屬衛教。	1. SDM 工具內容 2. 病歷紀錄	1. 病歷上宜有記載相關向病人與家屬說明之內容 2. 評量 8 分(含)以上應包含落實執行 SDM 且病人與家屬皆有參與。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
2.2.6 提供衛教資料與指導 目的：落實病人及家屬之衛教，依據照顧需求，提供衛教資料與指導。 2.2.6 應符合下述規範： 1. 評估病人及家屬的照顧需求，瞭解其是否有相同疾病、生活型態之問題，提供所需之衛教相關資料，包含：健康促進、疾病照護。 2. 協助病人及家屬瞭解病人的問題及衛教內容，並對於指導內容有具體評值機制。 3. 病人出院後利用隨機訪視（如：電訪）、居家訪視等方式評估其對於衛教內容之遵從度，有待加強項目應列為每次返院的衛教重點。	1. 衛教相關資料 2. 病歷紀錄	評量 8 分（含）以上應包含委員當日抽審之病歷皆符合本基準評量說明。
2.2.7 病人出院計畫 目的：跨領域團隊成員一同擬定病人出院計畫，重視照護之連續性，並有出院後之諮詢服務窗口，提供相關服務及追蹤。 2.2.7 應符合下述規範： 1. 病人出院計畫由團隊共同參與擬訂，並有考慮醫療照護之持續性。 2. 各團隊成員落實出院計畫，包含： (1) 病人適當之相關衛教（如：營養、復健、用藥、後續追蹤、自我照護等），並能以書面或電子資料提供給病人。 (2) 使用植入式儀器、呼吸器、管路或造口等時，應提供相關照護服務與	1. 病人出院計畫 2. 出院計畫執行狀況管理機制，如生活型態、用藥遵從性等	

評量項目	建議佐證文件	委員共識
指導，如：傷口照護、儀器異常反應之處理辦法，並定期追蹤評估。 (3) 住院期間及出院後所需之資源（如：保險、社區資源、轉介等）。 (4) 主動提供並協助預約回診追蹤。 3. 有適合之專業人員擔任出院後之諮詢服務窗口並提供相關服務及追蹤。 4. 對於出院計畫執行狀況應有監測執行成效之機制。		
2.2.8 高危險群病人之照護標準作業規範 目的：團隊依據高危險群病人定義，訂有照護之標準作業程序，以維護病人安全及品質。 2.2.8 應符合下述規範： 1. 針對該疾病之高危險群病人，訂定並執行照護標準作業規範，提供完整、一致、安全的醫療照護服務。 2. 正確並落實執行相關標準作業程序，並有監測、檢討及改善機制，以確保病人安全及其品質。 註：高危險群病人定義應包含之類別請參考基準 2.1.2。	1. 高危險群病人定義 2. 高危險群病人照護標準作業規範	評量 6 分(含)以上應包含頭頸癌照護團隊有針對頭頸癌照護之「高危險群病人」訂有照護標準作業規範；評量 8 分(含)以上應包含有檢討改善。
2.2.9 高風險醫療照護行為之標準作業規範 目的：團隊針對高風險醫療照護行為訂有標準作業程序，以維護病人安全及品質。 2.2.9 應符合下述規範：	1. 高風險醫療照護行為定義 2. 高風險醫療照護行為之照護	評量 6 分(含)以上應包含頭頸癌照護團隊有針對頭頸癌照護之「高風險醫療照護行為」訂有

評量項目	建議佐證文件	委員共識
1. 針對高風險之醫療照護行為，訂定並執行照護標準作業規範，提供完整、一致、安全的醫療照護服務。 2. 正確並落實執行相關標準作業程序，並有監測、檢討及改善機制，以確保病人安全及其品質。 3. 高風險醫療照護行為，應至少包含： (1) 高致吐性藥物之止吐規範。 (2) 是否有針對血球低下的處理規範。 (3) 年長病人的手術、化療、標靶治療的風險評估。 (4) 噎咳造成吸入性肺炎的評估與預防。 (5) 體重短期內減輕 10% 以上的評估與介入。 (6) 潛在性大出血病人的評估。	標準作業規範	照護標準作業規範；評量 8 分(含)以上應包含有檢討改善。
2.2.10 手術/處置前、中、後之照護標準作業規範 目的：團隊針對相關手術/處置訂有標準作業程序，以維護病人安全及品質。 2.2.10 應符合下述規範： 1. 訂定術前照護標準，含同意書、手術或處置說明書、病人術前訪視評估（病史、相關危險因子、病人有使用抗凝血劑、術前預防性抗生素之使用、檢驗值、告知治療計畫、併發症、風險）、手術部位標記（需有病人參與）、病人運送。	1. 手術/處置定義 2. 知情同意書、手術及處置同意書 3. 術前照護標準作業規範 4. 術後照護（含麻醉後）照護	若機構提供為全院性之作業規範，委員得檢視內容是否適用於頭頸癌。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
2. 團隊於手術/侵入性處置開始前，應確實執行確認步驟 (time-out)，確認內容包含病人辨識、確認手術名稱、確認手術位置、相關同意書確認完成。 3. 訂定術後照護含麻醉後照護、病人轉出作業規範、病人運送作業規範。 4. 手術/處置項目，應至少包含： (1) 根治性手術。 (2) 重建手術。 (3) 放射線治療。 (4) 系統性藥物治療 systemic therapy (化學、標靶、免疫等)。 (5) 治療後之復健。	作業規範 5. 病歷紀錄、手術紀錄 6. 病人轉出作業規範 7. 病人運送作業規範	
2.2.11 檢查/檢驗前、中、後之標準作業程序 目的：團隊針對檢查/檢驗訂有標準作業程序，建立緊急且重要之異常值或檢查報告說明及即時通報機制，並有回復及確認後續處置之機制，以維護病人安全及品質。 2.2.11 應符合下述規範： 1. 明確訂定各項與疾病相關檢查/檢驗前、中、後之標準作業程序。 (1) 對於緊急檢查、非上班時間之檢查需求，有適切的因應措施。 (2) 對於檢體收集、運送、危急值報告及結果報告，有合宜之規定。 (3) 特殊檢查、檢驗、處置之理由及結果應適時及適切地記載於病歷。	1. 檢查/檢驗項目定義 2. 疾病相關檢查標準業程序與紀錄 3. 異常值或檢查報告作業規範及即時通報機制	

評量項目	建議佐證文件	委員共識
2. 建立緊急且重要之異常值或檢查報告說明及即時通報機制，相關人員對於緊急且重要之異常結果應立即通報，並有回復及確認後續處置之機制。 3. 落實執行檢查標準作業程序與記錄。 4. 檢查標準作業程序應有定期檢討及修訂之機制。 5. 檢查/檢驗項目，應至少包含： (1) 切片檢查（含粗針穿刺）。 (2) 影像檢查。 (3) 細針抽吸細胞檢查。 (4) 血液學檢查。 註：其他未列舉之檢查/檢驗項目，請機構依自身特色自行訂定。		
2.2.12 用藥管理 目的：團隊應落實藥物管理，依循全院標準執行藥物治療標準作業程序，並訂定相關標準作業指引。 2.2.12 應符合下述規範： 1. 依循全院標準執行藥物治療標準作業程序，包含： (1) 藥物儲存注意事項 (2) 開立醫囑程序及注意事項 (3) 確認醫囑程序及注意事項	1. 藥物治療標準作業程序 2. 高警訊藥物、管制藥物之標準作業指引 3. 自備藥使用規範	1. 門診化療藥物調劑藥局為重點查證單位。 2. 評量 8 分(含)以上應包含皆符合評量說明之規範。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
(4) 調劑藥物及注意事項 (5) 藥物運送及注意事項 (6) 給藥及注意事項 (7) 監測使用藥物後的反應及其成效 (8) 藥物之緊急、突發或異常事件處理原則 (9) 落實記錄（病歷書寫規範） 2. 對使用高警訊藥物（含高濃度藥物）、抗生素治療、管制藥物及各單位常備藥品，訂定相關標準作業指引。 (1) 處方開立時應有高警訊藥品之警示，包含藥品外觀、包裝、標示或名稱發音相似的藥品。 (2) 高濃度藥品僅備於必要之臨床照護，且外觀須清楚標示，並儲存於安全之環境。 3. 訂定需進行用藥監控管理之疾病相關藥品品項，並定期分析用藥狀況。 4. 病人自備藥品的管理。		

2.3 臨床照護之紀錄品質

重點說明：病歷記載主要是藉由記載檢視病人病情之發展及治療過程，並提供資訊給所有醫療團隊成員，以利團隊間的溝通。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
2.3.1 病人治療過程、後續追蹤之紀錄 目的：病歷應詳實記錄，包含治療過程、追蹤及相關照護服務。 2.3.1 應符合下述規範： 1. 病歷內容應能反應病人疾病狀況及病程發展，協助團隊成員做決定，並且使用適當之評估工具，反應病人嚴重度。 2. 病人治療、追蹤與疾病改變、相關照護服務及團隊會議結論應於病歷適切、適時反應其照護過程及品質。	1. 病歷紀錄 2. 團隊會議紀錄 3. 病歷審查作業規範	
2.3.2 病歷之標準化代號、縮寫、定義及方法 目的：病歷之診斷碼、處置碼、縮寫應符合標準化定義。 2.3.2 應符合下述規範： 1. 對於疾病照護計畫相關之診斷碼、處置碼、縮寫，有標準化之定義。 2. 使用標準化的診斷碼、處置碼，並監測其使用狀況。 3. 使用標準化之縮寫，並訂定及監測不可使用的縮寫。	病歷標準化代號、縮寫、定義及方法	

第三章、品質提升及成果

3.1 品質監測

重點說明：團隊應訂定疾病照護品質提升計畫，並善用品質指標進行品質持續監測、以及發展團隊照護特色。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
3.1.1 品質監測指標 目的：團隊應依疾病特性，訂有該疾病照護相關品質監測指標項目及閾值，每年檢討改善。 3.1.1 應符合下述規範： - 訂定疾病照護過程面監測指標項目與閾值，每年評估檢討修訂監測指標項目及改善目標。 - 訂定疾病照護結果面成效監測指標項目與閾值，每年評估檢討修訂監測指標項目及改善目標。	- 品質指標項目與閾值 - 團隊會議紀錄	
3.1.2 品質監測機制 目的：團隊應訂有品質監測機制，並確保指標收集之正確性及一致性。 3.1.2 應符合下述規範： 制訂品質監測指標設計、收集、審核、分析、回饋及改善的制度，確保資料收集的時效性、準確性、完整性，並有熟悉該疾病照護之專業人員負責執行。	- 品質指標監測機制 - 指標人員培訓紀錄或證明 - 團隊成員教育訓練證明	評量 6 分(含)以上應包含頭頸癌照護團隊訂有品質指標之監測機制； 評量 9 分(含)以上應包含有進一步檢討改善。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
2. 對於機構內與指標收集與審核之相關人員有相關的培訓，並與品質管理相關單位人員進行討論，以確保執行正確性與一致性。 3. 指標項目之訂定依據臨床照護指引或實證醫學為基礎，並定期於團隊會議討論疾病照護品質監測結果。	4. 團隊會議紀錄	
3.1.3 臨床稽核機制 目的：團隊應訂有臨床稽核機制，並確保品質監測機制之正確性及一致性。 3.1.3 應符合下述規範： 1. 依據品質監測機制，應定期進行稽核，以確保品質監測機制之正確性。 2. 團隊訂有臨床稽核結果之回饋機制。	1. 臨床稽核機制 2. 團隊會議紀錄	
3.1.4 就醫經驗調查 目的：透過進行就醫經驗(Patient experience)調查，重視病人及家屬之看法及感受。 3.1.4 應符合下述規範： 1. 評核該疾病病人及家屬對於疾病照護之看法及感受，進行就醫經驗調查，並定期收集分析。	病人及家屬之就醫經驗調查	評量 6 分(含)以上應包含以頭頸癌病人為主進行病人就醫經驗調查； 評量 8 分(含)以上應包含有執行調查後之改善措施。

3.2 警訊事件及異常事件之通報管理流程

重點說明：團隊應針對警訊事件及異常事件進行通報、追蹤及原因分析，分析結果進行檢視與討論，並作為機構或照護團隊目標改善之依據，以提升人員及病人安全。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
3.2.1 警訊事件及異常事件之通報管理流程 目的：團隊應依疾病特性，針對可能發生之警訊或異常事件，建立病人安全通報及檢討機制。 3.2.1 應符合下述規範： 1. 依據疾病特性，辨識病人處置照護過程可能發生之警訊或異常事件，並建立病人安全通報及檢討機制。 2. 如發生跡近錯失、警訊事件及異常事件，有追蹤、分析、檢討改善之流程。 3. 運用事件分析結果，改善相關執行作法。 註：有關跡近錯失、警訊事件及異常事件之定義，請參考衛生福利部台灣病人安全資訊網，網址連結：https://reurl.cc/nZx4Ov。	1. 病人安全通報機制 2. 病人安全檢討機制 3. 異常事件改善做法 4. 團隊會議紀錄	評量 6 分(含)以上應包含皆符合評量說明之規範；評量 8 分(含)以上應包含有 PDCA 計畫。

3.3 品質成效

重點說明：照護團隊對於品質提升專案能落實執行，並有成效分析。

評量項目	建議佐證文件	委員共識
3.3.1 疾病照護品質提升專案 目的：團隊應推動品質提升相關活動，分析指標收集結果，進行檢討改善。 3.3.1 應符合下述規範： 1. 使用品質提升工具，以疾病照護層面整合及分析資料。 2. 運用品質監測指標收集分析結果，品質監測管理人員應將數值訊息適時回饋團隊，作為輔助管理營運決策及疾病照護改善之依據。 3. 過去2年有推動疾病照護品質提升專案且具成效，且專案成員需包含跨領域成員。 4. 醫療品質提升專案成果內化為醫療機構經常性措施。	疾病照護品質提升專案	評量6分(含)以上應包含運用頭頸癌癌症資料庫及其他品管手法進行分析；評量8分(含)以上應包含有相關成效。
3.3.2 臨床成效分析 目的：團隊應針對臨床成效進行監測及分析。 3.3.2 應符合下述規範： 1. 對於疾病照護計畫執行狀況應有監測執行成效之機制，如：死亡率、併發症、症狀減除、功能恢復等。	分析參加計畫病人之臨床成效 (參加前/後、有/無參加)	

評量項目	建議佐證文件	委員共識
3.3.3 醫療資源之整合與利用分析 目的：團隊應針對醫療資源的整合與利用，進行監測及分析。 3.3.3 應符合下述規範： 對於疾病照護計畫執行狀況，應對於醫療資源的整合與利用，有監測執行成效之機制，如：醫療成本、社區資源、明智選擇(Choosing Wisely)^{註1}、韌性(Resilience)^{註2}、數位轉型等，並可分析導入整合照護模式前、後於成本與資源之差異。 註1：明智選擇(Choosing Wisely)定義：促進醫病溝通及減少醫療浪費；如何幫助病人選擇(1)據醫學證據支持的治療(2)避免重複進行相同檢驗或醫療處置(3)遵行不傷害原則(4)對病人而言真正必要的治療方式。 註2：韌性(Resilience)定義：泛指人或物體具有彈性、韌性或抗壓性，即便受外力擠壓仍能迅速恢復的一種力量或特質。	分析參加計畫病人之成本與資源差異（如應符合規範第1點所提之醫療成本、社區資源、明智選擇、韌性、數位轉型等）	有關「明智選擇」及「韌性」之定義請參考註解說明，「明智選擇」及「韌性」之範例可參考附件。
3.3.4 資訊化成效 目的：鼓勵團隊導入資訊化系統，輔助團隊運作及溝通，並整合病人照護相關資料。 3.3.4 應符合下述規範： - 藉由資訊化作業流程增進及輔助團隊運作。 - 透過資訊化的資料彙整，可提供管理階層決策使用。	- 資訊系統畫面 - 團隊會議紀錄 - 資訊系統之成效與實例	

評量項目	建議佐證文件	委員共識
3. 藉由適當的會議，分析討論相關資訊，分析之結果可運用於醫療照護品質改善並持續進行。		
3.3.5 創新照護特色展現 目的：鼓勵機構及團隊導入創新照護技術及模式，並發展團隊照護特色。 3.3.5 應符合下述規範： 1. 有進行資源整合及提出創新照護特色內容、模式之作為。 2. 能配合醫學發展趨勢，導入創新照護技術、照護模式，展現機構照護特色。 3. 創新內容應符合相關法規規定。	1. 呈現團隊照護特色 2. 團隊發展計畫 3. 團隊會議紀錄 4. 創新照護之成效與實例	建議團隊創新照護特色呈現範圍包含參與相關醫療照護獎項（如國家醫療品質獎-系統類卓越中心）、針對認證成效發表論文（如：利用資訊系統蒐集數據並分析，使個案管理師能提早介入，以達早期發現早期治療）等；另，除醫療照護層面之外，亦可自新興科技或管理層面上展現創新特色。

附件、評量項目 3.3.3 之「明智選擇」及「韌性」範例

一、「明智選擇」之範例相關說明如下：

(一) 針對頭頸癌相關「明智選擇」之臨床措施舉例內容如下：

1. 單純的 cT1N0 的口腔癌，不應將正子攝影列入常規檢查。
2. 下咽癌、HPV non-related 口咽癌、上喉癌的病人必須要做食道內視鏡的檢查。
3. 未更改治療計畫前應依循原治療計畫。
4. 病人追蹤沒有變化，則不要在每次回診時進行影像學檢查。
5. 對主訴為聲音嘶啞的病人（patients with a primary complaint of hoarseness prior）不要在喉部檢查前進行 CT 電腦斷層掃描（Computed Tomography, CT）或核磁共振造影檢查（Magnetic Resonance Imaging, MRI）。

(二) 其他範例可參考美國內科醫學委員會(ABIM)基金會彙整之措施(網址連結：<https://reurl.cc/aaE6rG>)。

二、「韌性」之範例相關說明如下：

(一) 依相關理論而言，係指個體面對風險時，能透過學習訓練或環境改變加以強化並「積極恢復」至正向情緒之因應策略。

(二) 110-113 年之第九期「建構敏捷韌性醫療照護體系計畫」強調推動對於未來全球環境趨勢及國內社會結構變遷等挑戰之應變能力，持續以保障全體國民不論身處何地，均能享有周全性(Comprehensive)、持續性(Continuity)及協調性(Coordinated)的健康照護服務。

(三) 以面對 COVID-19 疫情，醫療照護體系需迅速調整並尋找新的方法以取得平衡為例。

1. 國家政策：物資供應充足、擴大疫苗接種、降載醫療業務、降低醫療人力負荷、增加照護專業津貼提高面臨風險照護誘因、遠距醫療提供無縫健康照護等。
2. 醫療組織：分艙分流維持醫護照護能量、提供員工安全且舒適之宿舍以降低感染同住家人風險、避免感染之良好動線設計及因應感控防護智慧醫療照護設備運用等。
3. 個體：員工關懷、家庭支持、用餐隔板維持適當距離、社會捐贈鼓勵臨床專業、提供臨床人員足夠防護裝備等。